

Nie lenistwo — *neurobiologia*

ADHD to nie wybór, nie wada charakteru, nie „złe nawyki”. To zaburzenie neurorozwojowe występujące u 3–5% dorosłych.

CZAS: 15 min czytania Po świeżej diagnozie — fundament

ŹRÓDŁO: Barkley (2015); APA (2022, DSM-5-TR); NICE NG87 (2018)

JAK UŻYWAĆ

Naucz się **trzech rdzeniowych domen** ADHD: nieuwaga, impulsywność, nadruchliwość. Rozpoznaj *swoją prezentację* (nieuwagowa, hiperaktywno-impulsywna, łączona). Zrozum, że ADHD u dorosłych **wygląda inaczej** niż u dzieci — hiperaktywność zwykle przechodzi w *wewnętrzną niepokój*, gonitwę myśli.

DLACZEGO TO DZIAŁA

ADHD to zaburzenie **neurorozwojowe** (Barkley, 2015; DSM-5-TR, 2022). Mechanizm: *deficyt dopaminy i noradrenaliny* w korze przedczołowej → osłabione funkcje wykonawcze (planowanie, organizacja, hamowanie, pamięć robocza). Częstość u dorosłych: **2,5–4%**. Początek przed 12 rokiem życia (kryterium DSM-5) — ale często niediagnozowane do dorosłości, szczególnie u kobiet i osób kompensujących wysiłkiem. **75%** ADHD dziecięcego trwa do dorosłości (Faraone i wsp., 2006). To *nie jest brak inteligencji* — osoby z ADHD często są bardzo inteligentne, ale mózg **inaczej zarządza** uwagą i energią.

01 Trzy domeny ADHD

1 · NIEUWAGA

8 objawów DSM-5

- Rozproszenie
- Zapominanie
- Gubienie rzeczy
- Trudność z organizacją
- Unikanie zadań wymagających skupienia
- Brak słuchania
- Niedotrzymywanie szczegółów
- Trudność z dokończeniem

2 · IMPULSYWNOŚĆ

4 objawy DSM-5

- Pochopne decyzje
- Przerwanie innym
- Trudność z czekaniem
- Mówienie bez przemyślenia

U dorosłych: *impulsywne zakupy, zmiany pracy, ostre wiadomości.*

3 · NADRUCHLIWOŚĆ

5 objawów DSM-5

- Wiercenie się
- Trudność z usiedzeniem
- Gadatliwość
- Nadmierna aktywność
- „Jakby napędzany silnikiem”

U dorosłych: *wewnętrzny niepokój, gonitwa myśli.*

02 Trzy prezentacje — Twoja

NIEUWAGOWA

Dominuje rozproszenie, marzycielstwo, zapominanie. **Bez widocznej hiperaktywności.** Częstsza u kobiet i dorosłych. Często niediagnozowana.

HIPERAKTYWNO-IMPULSYWNA

Dominuje wiercenie się, impulsywność, gadatliwość. **Bez wyraźnych problemów uwagi.** Częstsza u dzieci, rzadsza u dorosłych jako czysta forma.

ŁĄCZONA

Objawy z obu domen. **Najczęstsza prezentacja** u dorosłych z diagnozą. Wymaga wielokierunkowych strategii.

03 Co tu jest nie tak — neurobiologia w skrócie

NEUROPRZEKAŹNIKI

Dopamina i noradrenalina w korze przedczołowej są *słabsze niż w mózgu neurotypowym*. To są te same neuroprzekaźniki, które wpływają na motywację, uwagę, hamowanie impulsu. Leki stymulujące działają, bo **uzupełniają niedobór**.

FUNKCJE WYKONAWCZE

ADHD to zaburzenie **funkcji wykonawczych** — czyli zdolności mózgu do *planowania, organizowania, hamowania impulsu, pamięci roboczej*. Nie brakuje Ci „siły woli” — brakuje Ci **biologicznego paliwa** do jej wykorzystania.

DZIEDZICZNOŚĆ

74% (Faraone i wsp., 2005) — jedno z najsilniej dziedziczonych zaburzeń psychicznych. Jeśli masz ADHD, statystycznie *jedno z rodziców* również je ma (często niediagnozowane). To **biologia rodzinna**, nie wpływ środowiska.

TRWAŁE

ADHD *nie znika* z dorosłością — zmienia formę. Hiperaktywność dziecięca → wewnętrzny niepokój, niezdolność do odpoczynku. **75%** przypadków dziecięcych trwa do dorosłości. Leczenie to **zarządzanie**, nie wyleczenie.

04 Leczenie — trzy filary

1 · FARMAKOTERAPIA

Stymulanty (metylofenidat, amfetamina) lub niestymulanty (atomoksetyna, guanfacyna).

Najsilniej udokumentowana interwencja. Dobiera lekarz-psychiatra.

2 · TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

CBT specyficzna dla ADHD — pracuje nad strategiami kompensacyjnymi, wstydem, RSD, perfekcjonizmem. Safren i wsp. (2017): $d = 0,8-1,2$.

3 · STYL ŻYCIA

Sen, ruch, posiłki, uważność (ang. *mindfulness*), eksternalizacja. Każdy z osobna daje umiarkowany efekt. Razem — silnie wspierają lek i terapię.

Klucz: ADHD *nie jest* brakiem inteligencji ani brakiem charakteru. Jest **biologiczną różnicą** w okablowaniu mózgu — tak jak cukrzyca jest różnicą w pracy trzustki. Nie wstyd mieć ADHD. Wstyd jest, że tak długo nikt nie nazywał tego, co czujesz. Barkley (2015): „ADHD to nie deficyt uwagi — to deficyt motywacji opartej na nagrodzie i hamowania. Uwaga jest jedynie widocznym objawem”. Zarządzanie ADHD to **styl życia**, nie epizod leczenia. Jak cukrzyca: leczysz, zarządzasz, żyjesz pełnią.